

Question 21: La Fibrose néphrogénique systémique

- A. Atteinte cutanée puis systémique des articulations, du cœur et des poumons.
- B. Peut-être responsable du décès du patient.
- C. Secondaire à l'injection de chélateurs du gadolinium lors d'examen IRM.
- D. Survient chez des patients insuffisants rénaux avec une clearance de la créatinine $< 30 \text{ ml/min}$.

Question 22: La tomosynthèse :

- A. Imagerie mammaire tridimensionnelle (3D).
- B. Imagerie mammaire bidimensionnelle (2D).
- C. Acquisition des images, d'un sein compressé, se fait sous différents angles.
- D. Reconstruction des images en haute résolution (1 mm d'épaisseur) étagées sur tout le sein.

Question 23: Les critères de qualité d'un cliché de face en mammographie :

- A. Muscle pectoral doit être visible jusqu'à hauteur du mamelon.
- B. Le sillon sous-mammaire doit être visible sur le cliché.
- C. Mamelon en position médiane.
- D. Lane graisseuse rétro glandulaire bien dégagée.

Question 24: En mammographie, la compression du sein permet de :

- A. Diminuer l'épaisseur du sein.
- B. Limiter les superpositions en refoulant les tissus voisins.
- C. Augmenter le contraste.
- D. Améliorer la définition des contours.

Question 25: En IRM, les antennes en réseau phasé :

- A. Constituent un ensemble de plusieurs antennes de surface de petit diamètre, disposées côte à côte.
- B. Constituent un ensemble de plusieurs antennes de surface de petit diamètre, disposées face à face.
- C. Permettent un très bas signal sur bruit.
- D. Permettent un petit champ d'exploration.

Question 26: En IRM :

- A. Le blindage des ondes de radiofréquence est assuré par la cage de Faraday.
- B. Le blindage de champ magnétique a pour rôle de rapprocher les lignes de champ au plus près de l'aimant.
- C. Le blindage passif de champ magnétique est un ensemble de poutrelles d'acier ou de fer doux entourant l'aimant.
- D. Le blindage des ondes de radiofréquence est non assuré par la cage de Faraday.

Question 27: Urographie intra-veineuse :

- A. Permet de rechercher un reflux vésico-urétéral passif et actif chez l'enfant.
- B. Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices.
- C. Est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale.
- D. Est actuellement supplantée par l'uroscanner.

Question 28 : Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr :

- A. Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie
- B. Le Cliché sans préparation est obligatoire et permet de recherche des calcifications au niveau de l'hypochondre droit.
- C. L'injection du produit de contraste est suivie en scopie.
- D. L'injection du produit de contraste est rapide.

Question 29 : Un uroscanner :

- A. Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale.
- B. Est indiqué devant une obstruction urinaire.
- C. Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires.
- D. Est contre-indiquée en cas de créatinine sanguine à 20 mg/l.

Question 30 : En cas d'insuffisance rénale aigue :

- A. L'injection du produit de contraste iodé est contre-indiquée.
- B. Une hypohydratation avant et après l'injection de produit de contraste iodé doit être réalisée.
- C. Les médicaments néphrotoxiques doivent être arrêtés pendant au moins 48 heures.
- D. Un intervalle d'au moins 3 jours entre deux injections de produit de contraste iodé s'impose.

Question 31 : La vaccination au Maroc commence :

- A. Immédiatement après la naissance.
- B. A une semaine de la naissance.
- C. A six semaines de la naissance.
- D. A dix semaines de la naissance.

Question 32 : Le programme de vaccination au Maroc vise à prévenir les maladies suivantes :

- A. L'hépatite virale C.
- B. L'hépatite virale B.
- C. La rubéole.
- D. La varicelle.

Question 33 : La prophylaxie correspond aux :

- A. Mesures entreprises pour traiter les cas
- B. Mesures entreprises pour éviter la survenue de la maladie.
- C. Mesures entreprises pour éviter la contagion de la maladie.
- D. Actions entreprises pour la prise en charge psychologique de l'entourage du malade.

Question 34 : L'indice synthétique de fécondité au Maroc en 2013 est de :

- A. Un enfant par femme.
- B. Deux enfants par femme.
- C. Trois enfants par femme.
- D. Quatre enfants par femme.

Question 7 : L'orthopantomographie

- A. Est réalisée en position debout ou assise
- B. Incidence impossible à réaliser en décubitus
- C. La mandibule repose sur un évier ou elle est calée
- D. La contention peut comporter un guide buccal et un serre-tête

Question 8 : Profil d'Arcelin

- A. Est une incidence de profil chirurgical de la hanche
- B. Patient en décubitus, membre inférieur à radiographier en flexion.
- C. La cuisse opposée est fléchie à 90° sur le bassin, la jambe fléchie sur cuisse.
- D. La cassette est appliquée contre l'aile iliaque du côté à radiographier.

Question 9 : Critères de réussite d'une incidence oblique du rachis cervical

- A. Bon dégagement des trous de conjugaison à tous les niveaux.
- B. Superposition des apophyses articulaires droite et gauche.
- C. Dégagement de toutes les interlignes articulaires.
- D. Bonne visualisation des pédicules du côté examiné.

Question 10 : Les critères de réussite d'une radiographie du bassin de face :

- A. Superposition de l'axe du sacrum et de la symphyse pubienne.
- B. Dégagement externe complet du grand trochanter.
- C. Petit trochanter coupé par la corticale de la diaphyse fémorale.
- D. Trous obturateurs symétriques.

Question 11 : Radiographie du rachis cervical « bouche ouverte » :

- A. Incidence de face antéro-postérieure.
- B. Permet la visualisation du processus odontoïde et l'atlas.
- C. Rayon directeur est horizontal.
- D. Réalisée en décubitus en cas de traumatisme important.

Question 12 : Incidence de Lamy :

- A. Incidence de profil de l'épaule.
- B. Réalisée chez un sujet en position debout en oblique antérieure de 45 à 60° du côté examiné.
- C. Le bras est pendant, coude fléchi et légèrement porté en arrière.
- D. Rayon directeur est horizontal.

Question 13 : Radiographie de face de la clavicule:

- A. Rayon directeur est postéro-antérieur.
- B. Rayon directeur est horizontal.
- C. Visualisation de la clavicule dans sa totalité.
- D. Visualisation des articulations acromio-claviculaire et sterno-claviculaire.

Question 14 : Les critères de réussite d'une incidence du genou de profil :

- A. Superposition des condyles fémoraux.
- B. Bords interne et externe de la patella superposés.
- C. Patella se projetant sur les condyles.
- D. Interlignes fémoro-tibial et fémoro-patellaire bien dégagés.

Question 15 : Incidence de Gosserez-Treheux :

- A. Incidence ne permettant l'analyse que des os propres du nez.
- B. Montre l'ensemble du massif facial.
- C. Réalisée chez un patient assis.
- D. Peut être réalisée chez un patient en décubitus dorsal.

Question 16 : Incidence Blomdau :

- A. Est une incidence qui permet d'analyser les sinus antérieurs et postérieurs.
- B. Équidistance des condyles auditifs externes par rapport à la cassette.
- C. Centrage à la base du nez.
- D. Appel au nez.

Question 17 : En IRM, le TR :

- A. Est le temps de répétition.
- B. Est le temps écoulé entre deux impulsions de 180° .
- C. Détermine le niveau de repousse de l'aimantation longitudinale à la fin de chaque cycle.
- D. Si le TR est court, la courbe de repousse de l'aimantation longitudinale ne récupère pas son niveau initial à la fin de chaque cycle.

Question 18 : En IRM, le temps d'écho (TE) :

- A. Temps écoulé entre l'impulsion de 90° et le recueil de l'écho de spin.
- B. A TE/2, l'impulsion 180° est émise.
- C. Détermine le moment précis où le signal est mesuré.
- D. Plus on raccourcit le TE, plus la séquence est pondérée en T_1 .

Question 19 : La séquence Flair :

- A. Est une séquence en inversion-récupération pondérée T2.
- B. Le signal de l'eau libre est « supprimé ».
- C. Séquence utilisée dans l'exploration médullaire.
- D. Séquence utile pour la recherche de l'œdème et de la gliose.

Question 20 : En IRM, l'artefact de mouvement :

- A. Est un des artefacts les plus fréquemment rencontrés.
- B. Se constitue lorsqu'il y a translation dans l'espace du segment étudié au cours de l'acquisition.
- C. Il a pour conséquence la dispersion du signal avec image nette de la structure en mouvement.
- D. Peut être périodique et aperiodique.